

La schizophrénie

Durée : 60 minutes

Niveau : Intermédiaire à Avancé (Étudiants en médecine, Internes en psychiatrie, Professionnels de la santé mentale)

Mots-clés : schizophrénie, psychose, trouble psychotique, symptômes positifs, symptômes négatifs, délire, hallucination, désorganisation, antipsychotiques, réhabilitation psychosociale

Objectifs Pédagogiques

- Définir la schizophrénie comme un trouble psychiatrique chronique et complexe.
- Décrire la physiopathologie, notamment l'hypothèse dopaminergique et le modèle neurodéveloppemental.
- Identifier les différentes dimensions symptomatiques : positive, négative, cognitive et de désorganisation.
- Maîtriser les critères diagnostiques de la schizophrénie selon le DSM-5.
- Établir le diagnostic différentiel d'un premier épisode psychotique.
- Décrire les principes de la prise en charge pharmacologique (antipsychotiques) et non pharmacologique.
- Comprendre l'importance de la détection précoce et de la prise en charge globale pour améliorer le pronostic.

Introduction et Contexte Scientifique

La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique et sévère appartenant au spectre des troubles psychotiques. Elle affecte environ 1% de la population mondiale et débute typiquement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. La maladie se caractérise par une triade de symptômes : des symptômes positifs (délire, hallucinations), des symptômes négatifs (retrait social, apathie, émoussement affectif) et un syndrome de désorganisation (discours et comportement). Des troubles cognitifs importants sont également au cœur de la pathologie et conditionnent le pronostic fonctionnel. Le diagnostic est clinique, basé sur des critères stricts (DSM-5), après élimination des causes organiques ou toxiques. La prise en charge est multimodale et au long cours, associant un traitement antipsychotique, pierre angulaire du traitement, à des interventions psychosociales indispensables (psychoéducation, TCC, remédiation cognitive, réhabilitation) visant à améliorer le fonctionnement et la qualité de vie du patient.

Définition et Épidémiologie

Définition:

La schizophrénie est un trouble mental chronique qui se manifeste par une perception de la réalité altérée (psychose), une désorganisation de la pensée et du comportement, ainsi qu'un retrait affectif et social. Elle entraîne une altération significative du fonctionnement personnel, social et professionnel.

Épidémiologie:

- Prévalence: Environ 0.7% à 1% de la population mondiale.

- Âge de début:
- Hommes: Pic entre 15 et 25 ans.
- Femmes: Pic plus tardif, entre 25 et 35 ans.
- Sex-ratio: Légère prédominance masculine (1.4 homme pour 1 femme).
- Facteurs de risque: Antécédents familiaux (forte composante génétique), complications obstétricales, migration, urbanité, usage de cannabis à l'adolescence.

Physiopathologie

La physiopathologie est complexe et non entièrement élucidée. Le modèle actuel est neurodéveloppemental et intègre plusieurs hypothèses.

1. Hypothèse Neurodéveloppementale:

La schizophrénie résulterait de l'interaction entre une vulnérabilité génétique et des facteurs de stress environnementaux précoces (prénataux, périnataux) qui altèrent le développement cérébral. Les anomalies cérébrales seraient présentes bien avant l'apparition des symptômes, qui ne se manifesteraient qu'à l'adolescence, période de maturation cérébrale finale (synaptic pruning).

2. Hypothèse Dopaminergique (révisée):

- Hyperactivité dopaminergique dans la voie méso-limbique: responsable des symptômes positifs (délire, hallucinations).
- Hypoactivité dopaminergique dans la voie méso-corticale (cortex préfrontal): responsable des symptômes négatifs et cognitifs.

3. Autres neurotransmetteurs:

- Dysfonctionnement du système glutamatergique (récepteurs NMDA).
- Implication du système sérotoninergique.

Tableau Clinique et Dimensions Symptomatiques

La symptomatologie est hétérogène et s'organise en plusieurs dimensions.

1. Dimension Positive (ou productive):

- Délire: Croyances fixes, irrationnelles, non partagées. Thèmes fréquents : persécution, référence, influence, mégalomanie. Mécanismes : interprétation, intuition, imagination.
- Hallucinations: Perceptions sans objet. Les plus fréquentes sont acoustico-verbales ('entendre des voix'), mais elles peuvent toucher toutes les modalités sensorielles.

2. Dimension Négative (ou déficitaire):

- Émoussement affectif: Réduction de l'expression des émotions (visage, voix).
- Alogie: Raréfaction du discours, réponses brèves.
- Aboulie / Apathie: Perte de motivation, d'initiative et d'énergie.
- Anhédonie: Incapacité à ressentir du plaisir.
- Retrait social / Asocialité.

3. Dimension de Désorganisation:

- Trouble du cours de la pensée: Discours diffluent, coq-à-l'âne, barrages, néologismes.
- Comportement désorganisé: Bizarre, inapproprié, sans but (ex: agitation, stéréotypies).
- Incongruence idéo-affective: Discordance entre les émotions exprimées et le contenu de la pensée.

4. Troubles Cognitifs:

- Sont un symptôme central de la maladie.
- Touchent: la mémoire de travail, l'attention, les fonctions exécutives (planification, flexibilité mentale), la cognition sociale.

Diagnostic et Critères (DSM-5)

Le diagnostic est clinique et repose sur les critères du DSM-5.

Critère A: Présence d'au moins 2 des symptômes suivants pendant une part significative du temps sur une période d'1 mois (au moins 1 des 3 premiers est requis):

1. Idées délirantes
2. Hallucinations
3. Discours désorganisé
4. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique
5. Symptômes négatifs

Critère B: Dysfonctionnement social / professionnel: altération majeure du fonctionnement dans un ou plusieurs domaines (travail, relations, soins personnels).

Critère C: Durée: Persistance de signes continus du trouble pendant au moins 6 mois. Cette période de 6 mois doit inclure au moins 1 mois de symptômes répondant au critère A (phase active).

Critères D, E, F: Exclusion:

- Le trouble schizo-affectif et le trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques ont été écartés.
- Le trouble n'est pas dû aux effets d'une substance ou à une autre affection médicale.
- En cas d'antécédent de trouble du spectre autistique, le diagnostic de schizophrénie n'est fait que si les idées délirantes ou les hallucinations sont au premier plan.

Diagnostic Différentiel

1. Autres troubles psychotiques:

- Trouble psychotique bref: < 1 mois.
- Trouble schizophréniforme: 1 à 6 mois.
- Trouble schizo-affectif: Présence simultanée d'un épisode thymique majeur (maniaque ou dépressif) avec les symptômes du critère A, et au moins 2 semaines de délire/hallucinations en l'absence de symptômes thymiques.
- Trouble délirant: Délire non bizarre, sans autre symptôme majeur de la schizophrénie.

2. Troubles de l'humeur avec caractéristiques psychotiques (bipolaire, dépressif).

3. Troubles liés à l'usage de substances (cannabis, amphétamines, cocaïne).

4. Affections médicales générales ('Psychoses Organiques'):

- Neurologiques: Épilepsie temporale, encéphalite, tumeur cérébrale, maladie de Huntington.
- Endocriniennes / Métaboliques: Dysthyroïdie, maladie de Cushing, troubles ioniques.
- Infectieuses / Auto-immunes: Neurosyphilis, VIH, encéphalite limbique.

Prise en Charge Thérapeutique

La prise en charge doit être précoce, continue et multimodale.

A. Phase Aiguë (Premier épisode ou rechute)

- Hospitalisation souvent nécessaire pour la sécurité, le bilan et l'instauration du traitement.
- Traitement pharmacologique: Antipsychotiques.

B. Pharmacothérapie (Antipsychotiques / Neuroleptiques)

- Antipsychotiques de 2ème génération (ASG / 'atypiques'): Risperidone, Olanzapine, Aripiprazole, Quétiapine. Prescrits en 1ère intention pour leur meilleure tolérance neurologique (moins d'effets extrapyramidaux).
- Antipsychotiques de 1ère génération (APG / 'typiques'): Halopéridol. Efficaces sur les symptômes positifs mais plus d'effets secondaires moteurs.
- Cas particulier: Clozapine. Réservée à la schizophrénie résistante (échec de 2 autres antipsychotiques). C'est le plus efficace mais avec un risque d'agranulocytose nécessitant une surveillance hématologique stricte.
- Formes injectables à action prolongée (LAI): Utiles pour garantir l'observance.

C. Interventions Psychosociales (Indispensables)

- Psychoéducation (patient et famille): Comprendre la maladie, les traitements, les signes de rechute.
- Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCCp): Aident le patient à gérer les symptômes résiduels (voix, délire) et à modifier les schémas de pensée.
- Remédiation cognitive: Entraînement des fonctions cognitives déficitaires (mémoire, attention).
- Entraînement aux habiletés sociales.
- Prise en charge familiale (type psycho-éducationnelle).
- Réhabilitation psychosociale: Aide au logement, à la formation, à l'emploi (emploi accompagné).

Évolution et Pronostic

La schizophrénie est une maladie chronique avec une évolution très variable.

- Évolution: Souvent marquée par des phases de rémission et de rechutes. Une dégradation progressive du fonctionnement est fréquente, surtout en début de maladie.
- Règle des tiers (schématique): 1/3 des patients évoluera relativement bien avec une bonne autonomie, 1/3 aura une évolution intermédiaire avec des symptômes persistants et des difficultés, 1/3 évoluera de façon sévère et déficitaire.
- Facteurs de bon pronostic: Sexe féminin, début tardif et aigu, bon fonctionnement prémorbide, prédominance de symptômes positifs, bon soutien social, bonne observance.
- Facteurs de mauvais pronostic: Sexe masculin, début précoce et insidieux, mauvais fonctionnement prémorbide, prédominance de symptômes négatifs et cognitifs, abus de substances.
- Comorbidités: Dépression, anxiété, troubles addictifs (tabac >80%) sont fréquents.
- Espérance de vie: Réduite de 15-20 ans en moyenne, en raison du suicide, des accidents et des maladies cardiovasculaires.

Résumé final

La schizophrénie est un trouble neurodéveloppemental complexe qui altère profondément la pensée, les émotions et le rapport à la réalité. Son diagnostic, clinique, repose sur des critères stricts (DSM-5) et une durée d'évolution d'au moins 6 mois. La maladie combine des symptômes positifs, négatifs, de désorganisation et cognitifs. Si les antipsychotiques sont essentiels pour contrôler les symptômes aigus, une prise en charge

globale et intégrée, incluant un large éventail d'interventions psychosociales, est la seule approche permettant d'améliorer le pronostic fonctionnel à long terme, de favoriser le rétablissement et de préserver la qualité de vie des personnes atteintes.

Références Bibliographiques

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. (DSM-5). American Psychiatric Publishing; 2013.
2. Tandon R, Gaebel W, Barch DM, et al. Definition and description of schizophrenia in the DSM-5. *Schizophr Res.* 2013;150(1):3-10.
3. McCutcheon RA, Marques TR, Howes OD. Schizophrenia-An Overview. *JAMA Psychiatry.* 2020;77(2):201-210.
4. Collège National des Universitaires de Psychiatrie (CNUP). Référentiel de Psychiatrie et Addictologie. 3ème édition. 2021.